

REBAIXADO + MIOSE = OPIOIDE? NALOXONA

TOXIDROMES — OPIOIDE vs SEDATIVO-HIPNÓTICA

Achado	Opióide	Benzodiazepínico
Consciência	Rebaixamento / coma	Sedação, sonolência
Pupilas	MIOSE (puntiforme)	Geralmente normais
Respiração	DEPRESSÃO RESPIRATÓRIA marcante (bradipneia)	Depressão respiratória leve (pior se associado a álcool/opióide)
Sinal-chave	Tríade: rebaixamento + miose + bradipneia	Sedação com sinais vitais relativamente preservados
Antídoto	Naloxona	Flumazenil (uso restrito)
Risco principal	Parada respiratória	Depressão respiratória se coingestão

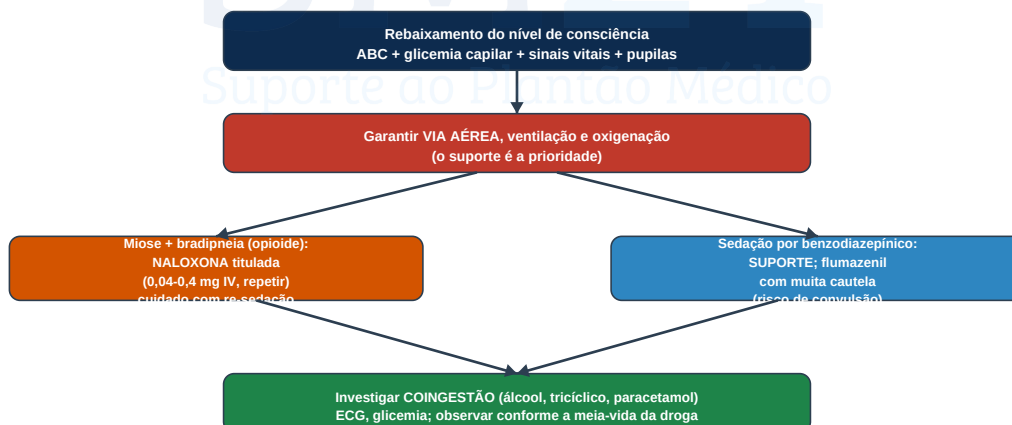
A PRIORIDADE É A VIA AÉREA E A VENTILAÇÃO

SUPORTE PRIMEIRO; ANTÍDOTO É ADJUVANTE

- O que mata na intoxicação por sedativos/opioides é a depressão respiratória — garantir via aérea, ventilação e oxigenação é a prioridade
- Opióide: naloxona titulada (0,04-0,4 mg IV, repetir) para reverter a depressão respiratória — não necessariamente acordar totalmente o paciente
- Atenção à meia-vida: a naloxona é curta; opioides de ação longa (metadona) podem exigir doses repetidas ou infusão (re-sedação)
- Flumazenil: uso **RESTRITO** — risco de convulsão em usuário crônico de benzodiazepínico ou em coingestão (ex.: tricíclico). **NÃO** usar de rotina
- Coingestões são comuns (álcool, tricíclicos, paracetamol) — checar glicemia, ECG e considerar paracetamol
- Observação prolongada se substância de ação longa ou liberação controlada

ABORDAGEM DO PACIENTE REBAIXADO POR SEDATIVOS

REBAIXADO -> ABC + GLICEMIA + TOXIDROME



ANTÍDOTOS E SUPORTE

Rx NALOXONA E FLUMAZENIL

Naloxona: 0,04-0,4 mg IV, repetir a cada 2-3 min até FR/ventilação adequadas (alvo: respirar, não necessariamente acordar)

Naloxona em infusão contínua: se opioide de ação longa (metadona) e re-sedação recorrente

Via alternativa: naloxona IM/intranasal se sem acesso venoso (contexto pré-hospitalar/overdose comunitária)

Abstinência por naloxona: agitação, dor, sudorese, taquicardia — titular para evitar (não dar bolus alto desnecessário)

Flumazenil: 0,2 mg IV (RESTRITO); EVITAR em usuário crônico de BZD, na coingestão de tricíclico/proconvulsivante e na dependência

Suporte ventilatório (O₂, ventilação com bolsa-máscara, IOT se necessário) é a base do tratamento

Checar glicemia, ECG (QRS/QT) e dosar paracetamol em intoxicação intencional

ARMADILHAS E CONTEXTO

Opióides — Cuidados

- Reverter a ventilação, não necessariamente acordar o paciente
- Meia-vida curta da naloxona x opioide de ação longa = risco de re-sedação
- Observação prolongada para metadona, oxicodona de liberação controlada, fentanil
- Edema pulmonar não cardiogênico pode ocorrer após reversão
- Considerar overdose acidental e tentativa de suicídio
- Encaminhar para suporte/tratamento da dependência

Benzodiazepínicos — Cuidados

- Isoladamente, raramente causam depressão respiratória grave em adulto
- Grave se associado a álcool, opioide ou outros depressores
- Flumazenil pode precipitar convulsão (abstinência) e arritmia (coingestão de tricíclico)
- Preferir o suporte clínico ao antídoto na maioria dos casos
- Avaliar risco de suicídio e coingestões
- Observar até a melhora do nível de consciência

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ ABC + glicemia em todo rebaixamento; garantir via aérea e ventilação (prioridade)
- ☐ Reconhecer a toxidrome opioide: rebaixamento + MIOSE + bradipneia
- ☐ Naloxona titulada para reverter a depressão respiratória (cuidado com re-sedação em opioide de ação longa)
- ☐ Flumazenil de uso RESTRITO (risco de convulsão); na maioria dos BZD, o suporte basta
- ☐ Investigar coingestões (álcool, tricíclico, paracetamol); ECG e glicemia
- ☐ Observar conforme a meia-vida da substância; avaliar risco de suicídio e encaminhamento

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com rebaixamento, pupilas puntiformes (miose) e FR de 6 irpm. Qual o diagnóstico e o antídoto?

- A) Intoxicação por benzodiazepínico — flumazenil
- B) Intoxicação por opioide — naloxona titulada, com suporte ventilatório
- C) Intoxicação por anfetamina — betabloqueador
- D) Intoxicação por organofosforado — atropina
- E) Intoxicação por álcool — tiamina

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Por que o flumazenil deve ser usado com muita cautela na intoxicação por benzodiazepínicos?

- A) Porque não reverte a sedação
- B) Porque pode precipitar convulsões (em usuário crônico) e é perigoso na coingestão de tricíclicos
- C) Porque causa miose
- D) Porque eleva a pressão arterial
- E) Porque é um opioide

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual é a prioridade no manejo da intoxicação por opióides/sedativos?

- A) Administrar o antídoto antes de qualquer medida
- B) Garantir via aérea, ventilação e oxigenação (suporte)
- C) Realizar lavagem gástrica de rotina
- D) Induzir o vômito
- E) Aguardar a eliminação espontânea

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Paciente respondeu à naloxona mas voltou a apresentar depressão respiratória após 40 minutos. Qual a explicação e a conduta?

- A) Falha do diagnóstico; suspender a naloxona
- B) A naloxona tem meia-vida curta e o opioide é de ação longa — repetir doses ou iniciar infusão contínua
- C) Administrar flumazenil
- D) Dar alta imediata
- E) Iniciar antibiótico

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Em uma intoxicação intencional por benzodiazepínico, qual coingestão NÃO pode deixar de ser investigada?

- A) Paracetamol (e outras, como álcool e tricíclicos)
- B) Vitamina C
- C) Ferro apenas
- D) Antiácidos
- E) Probióticos

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Rebaixamento + miose puntiforme + bradipneia é a toxidrome opioide. O antídoto é a naloxona, titulada para reverter a depressão respiratória, sempre com suporte ventilatório — que é a verdadeira prioridade.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O flumazenil pode precipitar convulsões em usuários crônicos de benzodiazepínicos (abstinência aguda) e é especialmente perigoso na coingestão de tricíclicos (remove o efeito anticonvulsivante do BZD). Por isso seu uso é restrito; o suporte clínico costuma ser suficiente.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A prioridade é o suporte: garantir via aérea, ventilação e oxigenação — pois é a depressão respiratória que mata. O antídoto (naloxona) é adjuvante. Lavagem gástrica e indução de vômito não são condutas de rotina.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A naloxona tem meia-vida curta; opióides de ação longa (ex.: metadona) podem causar re-sedação quando o efeito do antídoto termina. A conduta é repetir doses ou iniciar infusão contínua, com observação prolongada.

QUESTÃO 5 → Resposta: A

Em intoxicação intencional, deve-se sempre investigar coingestões — especialmente paracetamol (hepatotoxicidade tardia e tratável com N-acetilcisteína), além de álcool e antidepressivos tricíclicos. Checar também glicemia e ECG.

SM24
Suporte ao Plantão Médico